

갑상선암 진단 첫 30일

관찰 · 수술 범위 · 방사성요오드 결정

처음 진단받은 환자와 보호자를 위한 핵심 정리 · 질문 · 행동 가이드

ApuDa 「암 진단 첫 30일」 시리즈 05

MINI 무료 배포판 · Instagram 구독자용 · 2026년 10월 개정 2판

갑상선암은 ‘얼마나 빨리’보다 ‘얼마나 적절하게’ 치료하느냐가 중요합니다.

이 책을 펴기 전에

- 이 책은 **일반적인 환자교육 자료**입니다. 나의 병기, 치료 순서, 약 선택, 예후는 담당 의료진과 함께 결정합니다.
- 의학정보 확인일: **2026.10.04** · 참고 지침: NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology — Thyroid Carcinoma, Version 2.2026 외 국내 자료(본문 끝 「근거와 한계」 참고)
- 약의 국내 허가·건강보험 급여 기준과 제도(산정특례·지원사업)는 자주 바뀝니다. 실제 적용 전 병원 원무과·국민건강보험공단(1577-1000)에서 다시 확인하세요.
- 이 책은 NCCN이 검토하거나 승인한 자료가 아니며, ApuDa가 독자적으로 쓴 환자교육 저작물입니다.

이 MINI판에 대하여

이 MINI판은 진단 후 첫 30일 동안 **안전하게 판단하는 데 꼭 필요한 내용만** 담았습니다. 응급 신호, 진단 직후 할 일, 병리·병기의 핵심, 치료 흐름, 진료실 질문, 한 장 요약은 완전판과 같습니다. 30일 일자별 실행 로드맵, 치료별 준비·회복 가이드, 한국 제도·보험 서류 안내, 마음 돌보기와 보호자 가이드, 워크북은 완전판에 있습니다.

PART 1. 진단 첫 주 — 정확히 알기

1장. 먼저 구분하세요: 조직형과 위험도

30초 요약

- 갑상선암의 대부분은 **분화암(유두암·여포암)**으로 경과가 좋은 편입니다. 그러나 **저분화암·역형성암·수질암**은 치료가 다릅니다.
- 치료는 "빨리 전부 떼기"만이 길이 아니라 **위험도에 맞춘 선택**입니다: 적극적 관찰 / 엽절제 / 전절제 / 방사성요오드.
- 예후가 좋은 편이라는 것과 **지금 힘든 것은 함께 존재할 수 있습니다.** "착한 암"이라는 말에 마음이 다쳤다면 그 감정도 정당합니다.

조직형	특징	치료의 축
유두암	가장 흔함, 대개 천천히 자람	관찰 또는 수술 ± 방사성요오드
여포암	혈관을 통해 퍼질 수 있음	수술 ± 방사성요오드
호산성(옥시필) 세포암	이전 이름 '휘틀세포암'	수술 ± 방사성요오드(반응이 낮을 수 있음)
저분화암·고등급 분화암	분화암과 역형성암 사이	더 적극적인 수술·추적·분자검사
수질암	칼시토닌을 만드는 세포, 유전 가능성	수술 전 부신·부갑상선 확인, 유전검사
역형성암	드물고 빠르게 자람	신속한 다학제 진료 , 분자검사 (BRAF 등)
NIFTP	암이 아닌 저위험 종양으로 재분류	대개 엽절제로 충분

결과지 용어 연결

- **K-TIRADS 3/4/5:** 초음파로 본 악성 가능성 등급 — 확진이 아닙니다.
- **Bethesda 1~6단계:** 세침흡인 세포검사 결과(1 진단불가 / 2 양성 / 3 비정형 / 4 여포종양 / 5 악성 의심 / 6 악성).

오늘 물어볼 질문

1. 제 결과는 Bethesda 몇 단계이고, 조직형은 무엇인가요?
2. 적극적 관찰이 가능한가요, 수술이 필요한가요?
3. 수술한다면 엽절제와 전절제 중 무엇을 권하시나요?

2장. 기다리지 않는 신호

⚠ 응급 상자 수술 전·진행암

- 목 덩이가 빠르게 커짐, 숨이 차거나 쌉쌉거림, 삼키기 어려움, 피 섞인 가래, 갑자기 쉰 목소리 **수술 후**
- 목이 갑자기 붓고 숨이 참(출혈·혈종) → 즉시 응급실(119)
- 입 주위·손발 저림, 근육 경련·쥐(저칼슘) → 처방받은 칼슘을 먹고 바로 연락. 심하면 응급실
- 38°C 이상 발열과 상처 발적·고름
- 스스로를 해치고 싶은 생각 → ☎ 109, 119

본문 목록:

1. 빠르게 커지는 목 덩이·호흡곤란은 공격적인 갑상선암이나 출혈일 수 있습니다.
2. 수술 후 목 부종과 숨참은 혈종이 기도를 누르는 응급입니다.
3. 저림·경련은 부갑상선 기능 저하에 의한 저칼슘 신호입니다.
4. 상처 감염은 빨리 치료할수록 좋습니다.

3장. 진단 뒤 72시간

30초 요약: 오늘은 ① 세포검사 결과지 받기 ② 갑상선 전문 진료(내분비외과·내분비내과) 예약 ③ 임신 계획 메모. **대부분 서둘러 오늘 결정할 필요는 없습니다.**

오늘 할 일 (3개)

- ☐ 세포검사 결과지(Bethesda 단계)와 초음파 판독지(K-TIRADS) 사본
- ☐ 갑상선 전문 진료 예약
- ☐ 임신·수유 계획이 있다면 메모 — 관찰·수술·방사성요오드 모두 계획 단계부터 알려야 합니다

이번 주 할 일

- ☐ 목 림프절 초음파, 필요 시 CT(조영 CT는 방사성요오드 일정과 연결되므로 **순서를 의료진이 정함**)
- ☐ 혈액검사(갑상선 기능, 수질암 의심 시 칼시토닌·CEA)
- ☐ 산정특례 신청 여부 원무과 확인(확진 후 30일 이내; 적극적 관찰만 하는 경우 적용 여부 확인)
- ☐ 보험 약관에서 갑상선암 분류(유사암·소액암) 확인

오늘 물어볼 질문

1. 제 결절의 크기·위치·림프절 상태는 어떤가요?
2. 추가 검사(분자검사·CT)가 필요한가요?
3. 결정까지 시간은 얼마나 있나요?

4장. 병기와 위험도

30초 요약: 분화암은 **55세 기준**으로 병기 체계가 달라, 55세 미만은 원격전이 없으면 림프절 전이가 있어도 1기입니다. 치료 결정에는 병기보다 **재발 위험도(저·중간·고위험)**가 더 많이 쓰이며, 치료 후 반응에 따라 **다시** 평가됩니다.

재발 위험도	예시	흔한 접근
저위험	작은 종양, 갑상선 안에 국한, 공격적 소견 없음	관찰 또는 엽절제, 방사성요오드 대개 생략
중간위험	미세한 갑상선 밖 침범, 림프절 전이 일부 등	전절제 고려, 방사성요오드 선택적
고위험	육안적 침범, 원격전이, 불완전 절제	전절제 + 방사성요오드

- 치료 후 반응(혈액 티로글로불린·영상)이 좋으면 추적 간격과 **TSH 목표**가 완화될 수 있습니다.

 **완전판에서 이어집니다** — Bethesda 단계별 다음 단계, 가상 결과지 읽기

PART 2. 치료 결정 — 2~3주차

5장. 적극적 관찰

30초 요약: 1cm 이하 저위험 유두암 일부는 **바로 수술하지 않고 정기 초음파로 지켜보는 것이** 선택지입니다. 크기만이 아니라 **위치(기관·성대신경 가까이 있는지)·세포 소견·추적 가능성**을 함께 봅니다.

- 크기가 늘거나 림프절 전이가 나타나면 그때 수술로 바꿉니다. 국내 자료로는 5년 동안 지켜봤을 때 진행하는 경우가 10명 중 1명 정도이고, 나이가 많고 종양이 작을수록 더 적습니다. 진행해서 수술하더라도 대부분 완치를 기대할 수 있습니다. 적극적 관찰은 성인에게만 고려합니다.
- 관찰도 **치료 전략**입니다. "아무것도 안 하는 것"이 아닙니다.
- 임신 계획이 있다면 관찰 중 임신에 대해 미리 상의합니다.

■ **완전판에서 이어집니다** — 적극적 관찰 기록장

6장. 수술: 엽절제 vs 전절제

30초 요약

- **엽절제**: 한쪽만 제거. 호르몬제를 먹지 않아도 되는 경우가 많고 부갑상선·성대신경 위험이 낮습니다.
- **전절제**: 양쪽 모두 제거. 평생 갑상선호르몬제를 먹습니다. 종양이 크거나 양쪽에 있거나 갑상선 밖 침범·전이 있을 때, 또는 방사성요오드가 필요할 때 시행합니다.
- 엽절제 후 최종 병리에 따라 **남은 쪽 추가 수술(완결 갑상선절제술)**을 권유받을 수 있습니다. 처음 수술이 잘못된 것이 아니라 **정보가 추가된 결과**입니다.

비교	엽절제	전절제
호르몬제	필요 없을 수도	평생 필요
부갑상선 저하 위험	매우 낮음	일시적 저하 흔함(대개 1~2개월 안 회복), 영구는 약 1~2%
방사성요오드	불가	가능
추적	초음파	초음파 + 티로글로불린

- 수술 방법(목 절개, 로봇, 내시경, 입안 접근 등)은 흉터·비용·적응이 다릅니다. 우열보다 내 종양에 맞는지를 물어보세요.
- 국내에서는 갑상선 로봇수술이 아직 건강보험 급여가 되지 않아 비용 부담이 크고, 진행된 암에는 대개 권하지 않습니다. 합병증·재발 같은 결과는 목 절개 수술과 비슷하다고 알려져 있습니다. 예상 비용과 실손보험 적용 여부를 원무과에 미리 확인하세요(2026.10 기준, 확인 필요).

7장. 방사성요오드 치료

30초 요약: 방사성요오드는 **선택적**입니다. 저위험군은 대개 생략하고, 중간위험은 선택적으로, 고위험군에 주로 씁니다. 하게 된다면 **저요오드 식사**와 **TSH 올리기**가 준비의 핵심입니다.

- **저요오드 식사:** 치료가 정해지기 전에 미리 극단적으로 바꿀 필요는 없습니다. **일정이 정해지면** 병원 식단표대로 보통 1~2주 동안 **김·미역·다시마 등 해조류, 천일염·요오드 함유 소금, 해산물** 등을 제한합니다.
- **TSH 올리는 방법:** 갑상선호르몬제를 보통 치료 약 4주 전부터 끊는 방법(그동안 몹시 피곤하고 몸이 붓는 등 기능저하 증상이 생길 수 있어 운전·업무 일정 조정 필요) 또는 **재조합 TSH 주사**(일상 유지, 비용·급여 확인).
- 방사성요오드 예정이라면 다른 병원에서 **조영제 CT**를 찍기 전에 핵의학팀에 알려세요(일정이 밀릴 수 있음).
- 국내에서는 법 규정에 따라 투여 용량이 30mCi를 넘으면 며칠 동안 격리 병실에 입원해야 하고, 그보다 적으면 외래에서 먹고 집에 가기도 합니다. 내 용량과 입원 여부, 격리 병실 예약 시기를 미리 물어보세요(확인 필요).
- 치료 후 **임신·수유는 일정 기간 미룹니다**. 국내 안내로는 여성은 치료 뒤 적어도 6개월, 남성은 약 3개월이 지나서 임신을 계획하도록 권합니다. 치료 전에는 임신 여부를 먼저 확인합니다(투여량에 따라 다를 수 있어 담당 핵의학과 확인).

8장. 갑상선호르몬제와 TSH

30초 요약: 전절제 후에는 **평생 호르몬제**를 먹습니다. **아침 공복**, 같은 시간, 철분·칼슘제와 4시간 간격. TSH 목표는 위험도에 따라 다르며, 과도한 억제는 심장·뼈 부작용이 있어 개인별로 정합니다. 임신 중에도 계속 먹고, 임신 확인 즉시 용량을 상의합니다.

9장. 진행·재발성, 수질암·역형성암

30초 요약

- **방사성요오드 불응성** 분화암·저분화암: 진행 속도와 증상에 따라 관찰, 수술·방사선, **다중표적 표적치료제**(대표 예: 렌바티닙) 또는 **분자검사(BRAF·RET·NTRK 등)에 따른 표적치료** 범주(국내 허가·급여 확인 필요).
- **수질암:** 수술 전에 **부신(갈색세포종)·칼슘(부갑상선)** 검사를 했는지 확인하고, RET 유전검사와 가족 상담을 합니다.
- **역형성암:** 빠른 진행이 흔해 **며칠 안에 다학제 진료**와 분자검사(BRAF V600E 등)를 진행합니다.

진행·전이로 진단받았다면

30초 요약

- 전이가 있어도 치료 선택지는 있습니다. 치료 목표가 **암을 조절하며 오래, 덜 아프게 사는 것**으로 바뀌는 경우가 많습니다.
- **완화(지지)의료는 마지막 단계의 돌봄이 아닙니다.** 진단 시점부터 항암치료와 함께 통증·피로·숨참·불안을 줄이는 치료입니다.
- 첫 진료에서 "제 치료 목표는 무엇인가요?"를 꼭 물어보세요.

■ 완전판에서 이어집니다

- 치료 목표 대화법, 완화의료·호스피스 이용법, 사전연명의료의향서, 치료를 쉬는 선택
- 2차 소견 받는 법, 병원 선택 기준, 다학제 진료, 임상시험 찾는 법

PART 3. 30일 실행 로드맵

■ **완전판에서 이어집니다** — 30일 실행 로드맵(일자별 체크리스트)

PART 4. 치료 중·후의 몸과 마음

"착한 암"이라는 말과 과잉진단 논쟁

30초 요약: 과잉진단 논쟁은 **인구 집단의 검진 정책**에 관한 것입니다. 이미 진단된 내 결절의 치료 방침은 **내 결과로** 정합니다. 주변의 "별거 아니래"라는 말에 상처받았다면, 그 마음을 의료진이나 가족에게 말해도 됩니다.

■ **완전판에서 이어집니다** — 주변에 건넬 한 문장 예시, 검사 불안(스캔 불안) 다루기

추적

- 초음파와(전절제 시) 혈액 티로글로불린·항체로 추적합니다. 간격은 위험도와 치료 반응에 따라 조정됩니다.

■ **완전판에서 이어집니다** — 치료 중 증상별 자가관리 표(메스꺼움·피로·입안 혈음·변비·설사·불면·탈모·피부·손발 저림)

마음 돌보기

30초 요약

- 진단 후 불안, 잠 못 들, 멍함, 화, 눈물은 **흔하고 자연스러운 반응**입니다. 약해서가 아닙니다.
- 2주 넘게 일상이 무너지거나, 스스로를 해치고 싶은 생각이 들면 **혼자 견디지 말고** 바로 도움을 요청하세요.
- 자살·정신건강 위기 상담 ☎ **109**(24시간), 응급 ☎ **119**
- 지금 마음의 고통은 0~10 중 ____ 점. 4점 이상이면 다음 진료에서 그대로 말하세요.

■ 완전판에서 이어집니다

- 고통 온도계, 불안을 다루는 5분 방법, 상담 연결 경로, '내 탓' 생각 다루기
- 보호자 역할 나누기, 아이에게 알리는 법, 보호자 휴가 제도, 보호자 자신의 돌봄
- 직장 병행 전략, 회사에 말하는 범위, 복귀 계획
- 치료 중 식사·운동 원칙과 피해야 할 것

PART 5. 돈 · 서류 · 제도

한국에서 꼭 챙길 제도와 서류

30초 요약

1. **산정특례 등록**: 암 확진 후 **30일 이내**에 신청하면 확진일부터 건강보험 본인부담이 크게 줄어듭니다(급여 항목 기준 5%). 진단받은 병원 원무과에 "산정특례 신청"을 오늘 물어보세요.
2. **서류는 처음부터 두 부씩**: 병리보고서, 영상 판독지, 진단서는 보험·회사·2차 소견에 반복해서 쓰입니다.
3. **제도는 바뀝니다**: 금액·기준은 2026년 10월 기준이며, 공단(1577-1000)·원무과에서 다시 확인합니다.

 **완전판에서 이어집니다** — 산정특례 신청 절차, 의료비 지원제도, 실손·암보험 서류, 회사 서류 체크리스트

PART 6. 진료실 도구

진료실 질문 모음 — 한 번에 3개씩

진단 직후에는 1~3번, 치료를 정할 때는 4~7번, 치료 시작 전후에는 8~10번 중 **3개만** 골라 가세요. 보호자가 답을 적으면 충분합니다. 1. 조직형과 Bethesda 단계는요? 2. 크기·위치·림프절·갑상선 밖 침범은요? 3. 제 재발 위험도는 어디에 해당하나요? 4. 적극적 관찰이 가능한가요? 5. 엽절제와 전절제 중 무엇을 권하시나요? 6. 수술 방법별 장단점은요? 7. 방사성요오드가 필요한가요? 8. 호르몬제와 TSH 목표는 어떻게 되나요? 9. 임신·수유 계획은 어떻게 맞추나요? 10. 바로 연락해야 할 수술 후 증상은요?

내 갑상선암 한 장 요약

항목	내 기록
조직형	유두 / 여포 / 호산성 / 저분화 / 수질 / 역형성
크기·위치	_ cm , _
Bethesda / K-TIRADS	_ / _
림프절	_____
재발 위험도	저 / 중간 / 고
첫 치료	관찰 / 엽절제 / 전절제
방사성요오드	해당 없음 / 예정 / 완료
TSH 목표	_____
산정특례·보험	☐ 확인

오늘 꼭 물을 3가지: ① 관찰이 가능한가요? ② 수술 범위는? ③ 방사성요오드가 필요한가요?

■ 완전판에서 이어집니다

- 같은 진단을 받은 세 사람의 30일(가상 사례)
- 갑상선암 용어사전
- 갑상선암 자주 묻는 질문 12
- 진료실 대화법(15분 진료를 30분처럼), 검사 준비 카드(CT·MRI·PET·조직검사·내시경)
- 워크북: 진료 기록지, 7일 증상 일지, 약·보충제 목록, 연락처 카드, 30일 체크달력

근거와 한계

- **참고 지침:** NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology (NCCN Guidelines®) — Thyroid Carcinoma, Version 2.2026. NCCN의 표·알고리즘·문장을 옮기지 않고, 환자 언어로 새로 썼습니다.
- **국내 자료:** 국가암지식정보센터(www.cancer.go.kr) 갑상선암 정보, 대한갑상선학회·대한내분비외과학회 자료, 국민건강보험공단 산정특례 안내
- **국가암지식정보센터 자료의 이용 방식:** 이 책은 국가암지식정보센터(구 국가암정보센터)의 글·표·그림을 옮기거나 고쳐 쓰지 않았습니다. 같은 사실을 대조·확인하는 데 참고했고, 문장은 ApuDa가 새로 썼습니다(센터 저작권 안내의 이용조건: 비영리·저작권 표시·내용 변경 금지·영리 이용 시 사전 협의를 따릅니다).
- **출처:** 보건복지부·국립암센터 국가암지식정보센터 — 사실 확인에 참고한 자료(센터 문장·그림은 신지 않음). 더 자세한 암 정보와 상담은 www.cancer.go.kr, ☎ 1577-8899(평일 9~18시).
- **의학정보 확인일:** 2026.10.04. 약의 국내 허가·급여, 면역치료·표적치료 적용 기준, 제도 금액은 바뀔 수 있습니다.

- **감수:** ApuDa 「첫 30일」 감수단(전문의 30인·환자 36인·편집자문 3인 역할 기반 **AI 사전 검토단**)의 1·2차 검토를 반영했습니다. 이 검토는 실제 면허 의료진의 최종 감수를 대신하지 않습니다. 출판본에는 실제 감수자 명단이 별도 표기됩니다.
- 이 책은 NCCN이 검토·승인한 자료가 아니며, NCCN과 무관한 ApuDa의 독자적 환자교육 저작물입니다.
- 이 자료는 일반적인 환자교육용이며 개인의 진단·처방·치료 결정을 대신하지 않습니다.

완전판에는 이런 내용이 더 있습니다

- Bethesda 단계별 다음 단계, 가상 결과지 읽기
- 적극적 관찰 기록장
- 수술 후 2주 회복 일지
- 저요오드 식사 대체표, 치료 후 가족 수칙, 입원 짐
- 치료 목표 대화법, 완화의료·호스피스 이용법, 사전연명의료의향서, 치료를 쉬는 선택
- 2차 소견 받는 법, 병원 선택 기준, 다학제 진료, 임상시험 찾는 법
- 30일 실행 로드맵(일자별 체크리스트)
- 주변에 건넬 한 문장 예시, 검사 불안(스캔 불안) 다루기
- 치료 중 증상별 자가관리 표(메스꺼움·피로·입안 혈음·변비·설사·불면·탈모·피부·손발 저림)
- 고통 온도계, 불안을 다루는 5분 방법, 상담 연결 경로, '내 탓' 생각 다루기
- 보호자 역할 나누기, 아이에게 알리는 법, 보호자 휴가 제도, 보호자 자신의 돌봄
- 직장 병행 전략, 회사에 말하는 범위, 복귀 계획
- 치료 중 식사·운동 원칙과 피해야 할 것
- 산정특례 신청 절차, 의료비 지원제도, 실손·암보험 서류, 회사 서류 체크리스트
- 같은 진단을 받은 세 사람의 30일(가상 사례)

- 갑상선암 용어사전
 - 갑상선암 자주 묻는 질문 12
 - 진료실 대화법(15분 진료를 30분처럼), 검사 준비 카드(CT·MRI·PET·조직검사·내시경)
 - 워크북: 진료 기록지, 7일 증상 일지, 약·보충제 목록, 연락처 카드, 30일 체크달력
-

ApuDa.app — 더 많은 암·질환 교육 콘텐츠와 업데이트 Instagram 구독자 무료 배포판 · 상업적 재배포 금지

ApuDa | 아프지만, 다행이다. · <https://apuda.app/>